

三、药物相互作用

吩噻嗪类如氯丙嗪能加重本药的不良反应；抗胆碱药如阿托品能降低其作用。有潜在致畸作用，孕妇不宜应用。注射给药可引起直立性低血压。禁用于嗜铬细胞瘤、癫痫及进行放疗和化疗的乳腺癌患者。也禁用于胃肠活动增强可导致危险的病例，如胃肠出血、机械性肠梗阻或肠穿孔的患者。

胃复安发生不良反应，尤其是锥体外系反应发生率较高，与剂量偏大有关。成人30mg/日以下，

一般不出现锥体外系反应。肝肾功能不全时更应注意减量。

参 考 文 献

- 1.沈守信.中级医刊 1980; (4): 28
- 2.潘银英.新药与临床 1985; 4(1): 7
- 3.李 端.新药与临床 1982; 1(8): 119
- 4.郭佳士.新药与临床 1984; 8(1): 39
- 5.周仲康.新医学 1984; 15(11): 569
- 6.张效文,等.解放军医学杂志 1982; 7(8): 158
- 7.李 利.实用内科杂志 1986; 6(11): 625
- 8.耿阳细祖.实用内科杂志 1985; 5(5): 247

普罗帕酮的药物相互作用

大连医学院附属第一医院药剂科 徐永昭

普罗帕酮 (Propafenone hydrochloride) 是一种新型抗心律失常药, 1978年由德国首先生产, 1982年我国研制成功, 临床证明是一种较好的抗心律失常新药^[1]。现将其药物相互作用综述如下。

1. 普罗帕酮与地高辛: 普罗帕酮能使地高辛从血浆蛋白结合部位置换出来, 使血清地高辛浓度升高。有人报道36例受试者, 合用普罗帕酮150mg/日和地高辛0.375mg/日, 使血清地高辛浓度增加37%, 地高辛肾清除率下降83%, 心电图多见T波变平^[2]。还有人报道, 在5例患频繁室性早搏的病人, 以恒定剂量0.125~0.25mg的地高辛, 合用普罗帕酮900mg (以三次分服) 后, 血清地高辛浓度平均增加83%^[3]。国内有人报道, 二者合用治疗小儿顽固性心律失常36例, 不仅房速迅速终止, 而心功能明显改善。总之, 二者合用时, 应慎重, 有引起心功能恶化的报道^[4]。

2. 普罗帕酮与异搏定: 有人报道, 使用普罗帕酮治疗的1例病人, 因自服异搏定80mg, 加重了心脏传导阻滞, 导致了心、脑缺氧综合征^[5]。有的文献认为, 二者均呈负性肌力作用, 合用时可致心脏阻滞, 甚至停搏, 故认为二者不宜合用。

3. 普罗帕酮与安他心: 据报道, 有2例难治性早搏, 二者合并治疗, 取得了良好的疗效^[6]。

4. 普罗帕酮与乙胺碘呋酮: 二者呈协同的负性肌力作用, 可致QT显著延长, 诱发扭转室速, 一般宜合用, 如必须合用时, 普罗帕酮

半^[7]。还有人报道3例病人, 二者合用后引起了严重的窦性心动过缓, 需用心脏起搏器急救。

5. 普罗帕酮与利多卡因: 使用利多卡因无效的病人, 需改用普罗帕酮时, 应停用前者后再给药。二者一般不宜合用。

6. 普罗帕酮与奎尼丁: 二者合用时, 对心肌的抑制作用明显增强。普罗帕酮与奎尼丁相反, 能延长P—R及QRS间期, 缩短QT间期, 奎尼丁不影响普罗帕酮血浓度, 故二者合用甚理想, 能使剂量减少, 疗效增强^[8,9]。

7. 普罗帕酮与普鲁卡因: 有47例频发的复杂室性心律失常的病人, 普鲁卡因与奎尼丁合并治疗无效后, 加用普罗帕酮, 一周未复发, 不但疗效好, 且普罗帕酮的剂量亦小于单独用药, 副作用甚少, 认为安全有效^[9]。

8. 普罗帕酮与心得安: 二者合用时, 负性肌力作用相加, 可引起严重的心动过缓, 甚至心脏停搏, 故二者不宜合用。

9. 普罗帕酮与硝酸异山梨醇酯: 二者合用时, 可发生头晕, 对敏感的病人, 症状更明显, 故应慎重。

10. 普罗帕酮与华法林: 二者合用时, 对普罗帕酮的稳态血浆浓度和消除半衰期均无影响, 但可使华法林的稳态血浆浓度比单用时增高38%, 对消除半衰期影响不大, 对彼此的血清蛋白结合率也无显著的影响。但能使华法林的凝血酶原时间较单用

时明显延长,故认为,可增加华法林的抗凝作用。二者合用时,宜减少华法林的剂量^[10]。

11. 普罗帕酮与胃复安:胃复安能减轻或完全消除普罗帕酮引起的胃肠道反应^[4]。

12. 普罗帕酮与维生素B₆:普罗帕酮能引起胃肠道反应,合用维生素B₆时,这一反应能减轻或完全消除^[4]。

13. 普罗帕酮与局麻药:普罗帕酮具有负性肌力作用,在服药治疗期间,如使用局麻药时宜慎重,因能引起心动过缓,甚至心脏停搏。

14. 普罗帕酮与双异丙吡胺:二者均具有较强的负性肌力作用,合用时可致QT延长,能引起扭转室速,甚至出现心脏传导阻滞,心脏停搏,故不宜合用。如使用普罗帕酮的病人,需改换双异丙吡胺治疗,应停用普罗帕酮一天后,再服用。

15. 普罗帕酮与硫氮革酮:硫氮革酮为钙拮抗剂,负性肌力作用较强,二者合用时,能加强负性

肌力作用,可引起心脏传导阻滞,故文献上不主张二者合用。如必须合用时,应注意调整剂量,密切观察,最好进行监测。

参 考 文 献

1. 顾复生,等.中华内科杂志 1982; 11(21): 658
2. Belz GG, et al. Clin Pharmacol Ther 1983; 33: 410
3. Salerno DM, et al. Am J Cardiol 1984; 63: 77
4. 聂玉章,等.临床儿科杂志 1987; 5(2): 86
5. 崔世英,等.新药与临床 1988; 7(4): 246
6. 罗福康.浙江医学 1988; 10(4): 246
7. 徐永昭.中国急救医学 1987; 7(1): 45
8. Ladarola MJ, et al. Science 1982; 218: 1237
9. 向培斌.国外医学心血管病分册 1988; 15(6): 369
10. Kates RF, et al. Clin pharmacol Ther 1987; 42: 305

安定临床应用新进展

南京军区福州军医学校

苏开仲

安定为目前常用的镇静催眠药,临床上主要用于焦虑症及各种神经官能症、失眠等。静注给药为控制癫痫持续状态的首选药物。近年来发现本药有新的用途。

1. 治疗急性心肌梗塞左心衰:杨淑清等报道^[1],心肌梗塞早期用安定可控制焦虑,从而降低危重心律失常的发生率和缩小心肌损伤的范围。用法:开始静注10mg,1小时后口服15mg,其后每隔8小时口服15mg。

2. 治疗室性心律失常:静注给药治疗室性心律失常有效^[1],通常用药2分钟后即可使室性异位搏动和纤颤恢复为窦性心律。用法:发作时每次静注10~20mg。

3. 抗破伤风痉挛:国内近年来曾多次报道本药治疗破伤风的经验^[2-6],认为本药通过松弛肌肉和抗惊厥作用而控制破伤风的痉挛、牙关紧闭和强直,可降低破伤风的并发症和死亡率。经本药治疗的26例患者有23例痊愈,余3例因用药太晚或用量不足而死亡。用法:痉挛发作期每日0.7~1.3mg/

kg,分4次静注;高峰期每日2~5.3mg/kg,分4~6次静注;或每次静注10mg,每日6~8次给药。

4. 减少氯胺酮麻醉苏醒期的副作用:氯胺酮是一种脑代谢促进剂和脑血管扩张剂,其麻醉后往往合并幻觉幻梦等。若与安定复合麻醉即可减少氯胺酮麻醉苏醒期出现的恶梦等。肖福德报道^[7],120例各种手术病人随机分成两组,A组:术前肌注安定10mg和阿托品0.5~1mg,术后再静注安定5~10mg;B组:术前注射阿托品0.5~1mg。结果A组苏醒期发生恶梦者为1.7%,B组为21%,两组间有显著性差异。

5. 预防琥珀胆碱引起术后肌痛:全麻诱导快速气管内插管主要方法是用硫喷妥钠加琥珀胆碱。而琥珀胆碱能促使肌纤维成束收缩引起肌痛。国内文献报道,术前静注安定0.1~0.2mg/kg,观察184例患者肌痛的发生率为7~10%;而对照组肌痛发生率高达50%,有显著性差异。

6. 用于复合诱导麻醉:安定与硫喷妥钠复合